

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до менее 70 случаев на 100000 живорождений
Индикатор	Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками
2. Информация об организации	
Организация	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Процент родов, в которых участвуют квалифицированные медицинские работники (как правило, врачи, медсестры или акушерки), – это процент родов, в которых участвуют медицинские работники, прошедшие подготовку по оказанию спасательной акушерской помощи, включая предоставление необходимого надзора, ухода и консультаций женщинам во время беременности, родов и послеродовый период, проведение родов самостоятельно и уход за новорожденными. Традиционные акушерки, даже если они получают короткий учебный курс, не включаются.
Основные понятия:	
Обоснование и толкование	Наличие квалифицированного помощника во время родов является важным спасательным вмешательством как для матерей, так и для младенцев. Отсутствие доступа к этой ключевой помощи наносит ущерб здоровью женщин и реализации широких прав и возможностей женщин, поскольку это может привести к гибели матери или длительной инвалидности, особенно в маргинальных (особых, отдалённых) условиях.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Административные данные
Методы сбора данных	Данные поступают из административного источника, доступны на ежегодной основе
Единица измерения	Процент
Периодичность	Ежегодно
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Число женщин в возрасте 15-49 лет с квалифицированным медицинским персоналом (врачи, медсестры или акушерки) во время родов выражается в процентах от общего числа женщин в возрасте 15-49 лет с живыми рожденьями в тот же период
Комментарии и ограничения:	ЮНИСЕФ и ВОЗ ведут совместные базы данных о квалифицированной помощи при родах (врач, медсестра или акушерка), и обе организации сотрудничают в целях обеспечения согласованности источников данных. Обследования домашних хозяйств на национальном уровне являются основными источниками данных, используемых для сбора данных для показателей дородовой помощи. Эти обследования включают

	демографические и медицинские обследования (DHS), мультииндикаторные кластерные исследования (MICS), обследования репродуктивного здоровья (RHS) и национальные обследования, основанные на аналогичных методологиях. Обследования проводятся каждые 3-5 лет. Для промышленно развитых стран (где представлен высокий уровень охвата) источники данных включают в себя преимущественно статистику регулярной практики. До включения в объединённые глобальные базы данных, ЮНИСЕФ и ВОЗ проводят процесс проверки, который включает письменную коммуникацию с местными организациями для уточнения оценок. Во время этого процесса проверяются национальные категории квалифицированного медицинского персонала, так как в некоторых странах могут существовать дополнительные категории квалифицированного медицинского персонала, помимо врачей, медсестёр и акушеров.
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Уровень дезагрегации:	Данные дезагрегированы по месту проживания (городское/сельское), географических регионов
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	Несоответствия возможны, если на уровне учреждений здравоохранения собраны национальные данные. Они будут отличаться от глобальных показателей, которые основаны на данных обследования, собранных на уровне домашних хозяйств. Что касается данных обследований, то в некоторых отчётах об обследованиях может присутствовать общий процент рождений, в которых участвует квалифицированный специалист в области здравоохранения, который не соответствует определению ЦРТ (например, общее число включает в себя тех, кто не считается квалифицированным и специалистами, таких как общинные медико-санитарные работники). В этом случае процент родов, принимаемых врачом, медсестрой или акушеркой, суммируется и вводится в глобальную базу данных в качестве оценки ЦРТ. В некоторых странах, где не используется показатель помощи квалифицированного помощника при родах, вместо этого используется показатель рождений в медицинском учреждении (институциональные роды). Это часто наблюдается среди латиноамериканских стран, где доля институциональных родов очень высока. Тем не менее, следует отметить, что при использовании показателя институциональных родов процент родов с участием квалифицированного помощника может быть занижен.
8. Ссылки и документация	https://stat.gov.kz/ru/sustainable-development-goals/goal/3/